特徴的所見を捉えることが有用であった心房中隔脂肪性肥大の一例

◎伊藤 杏奈[1)]、小島 光司[1)]、伊藤 智恵[1)]、伊藤 康生[1)]、舟橋 恵二[1)]、榊原 慶祐[2)]、髙田 康信[2)]
JA 愛知厚生連 江南厚生病院[1)]、JA 愛知厚生連 江南厚生病院 循環器内科[2)]

【はじめに】
心房中隔脂肪性肥大（LHAS）は心臓良性腫瘍の約 10%という稀な疾患である．心エコー図検査（UCG）における診断基準は，心房中隔の肥厚が 15mm 以上であること，卵円窩は侵されず特徴的なダンベル様形態を有することなどとされている．今回，軽度の心房中隔肥厚であったが UCG にて特徴的な所見を捉えることにより，他の画像検査と併せて LHAS と診断された症例を経験したので報告する．

【症例】
患者は 70 代女性.インフルエンザ感染に伴う肺炎により当院を受診された方．経過観察を目的に実施された PET 検査により，心房中隔への放射性物質集積を指摘された．精査目的に UCG 及び MRI 検査を実施した．

【UCG 所見】
左室収縮能は良好である．軽度の僧帽弁及び三尖弁，肺動脈弁逆流症を認めるが心拡大は認めない．心窩部アプローチにおいて心房中隔に最大 11mm の肥厚を認める．卵円窩肥厚は認めず心房中隔はダンベル様形態を呈する．

【MRI 所見】
心房中隔の腫瘤様構造を認める．同部は T1・T2 強調画像にて軽度高信号を認め，周波数選択的脂肪抑制法において信号低下を認める．

【経過】
MRI 検査及び UCG にて心房肥大を認め，LHAS と診断された．現在は経過良好であり，経過観察中である．

【考察】
本症例は心房中隔のダンベル様肥厚という特徴的な所見を示しているが，心房中隔肥厚が軽度であることから非典型的な LHAS と考える．本症例のように診断基準に満たない軽度の心房中隔肥厚の場合では，心窩部アプローチによる心房中隔のダンベル様肥厚の検出が有用であり，その他画像検査と併せて臨床判断に寄与することが可能と考える．

【まとめ】
心房中隔肥厚が軽度である非典型的 LHAS の場合，心房中隔のダンベル様肥厚を捉えることで臨床診断の一助となることが示唆された．

連絡先：0587-51-3333